

КЛИНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Сыпь у беременных

Дифференциальная диагностика зудящих дерматозов беременности:
от безобидных до неотложных

Физиологические и патологические дерматозы беременности, дифференциальная
диагностика с инфекционными сыпями.

Один вызов: зудящая сыпь на животе у беременной 33 недель с единственным эпизодом
лихорадки.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 28 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Клинический случай

Вызов на «сыпь у беременной»

Беременная, 27 лет, первая беременность, срок 33 недели. Вызов от акушерской службы: «сыпь на животе, не бледнеет при надавливании, однократное повышение температуры до 38 °С».

При осмотре: самочувствие удовлетворительное, активная. Температура 36,8 °С, АД 118/75 мм рт. ст., ЧСС 88 в минуту, ЧД 16 в минуту, SpO₂ 99 %. Живот не увеличен, мягкий, безболезненный. Шевеления плода чувствуются, сердцебиение плода 140 в минуту.

На передней брюшной стенке — распространённая сыпь: мелкие красные пятна и папулы, местами сливающиеся в бляшки. При диаскопии элементы бледнеют. Сыпь зудит, пациентка отмечает усиление зуда в вечернее время. Сыпи нет на других участках тела, на конечностях, спине, лице. На животе — растяжки (striae gravidarum). Слизистые без изменений.

Акушерская служба не уверена в инфекционной природе сыпи, но фиксация подъёма температуры заставляет исключать инфекцию. Пациентка категорически отказывается от госпитализации в инфекционный стационар.

Вопросы для размышления

Ответы — в конце материала.

1. Какой первый вопрос относительно сыпи, который нужно задать до начала дифференциальной диагностики?
2. Почему сыпь на животе у беременной требует особого внимания и какие состояния нужно исключить в первую очередь?
3. PUPPP (Pruritic Urticarial Papules and Plaques of Pregnancy) — что это, каковы типичные сроки возникновения, локализация и прогноз?
4. Pemphigoid gestationis (герпесформный гестационный дерматит) — чем отличается от PUPPP, какие опасности для матери и плода?
5. Внутривенный холестаз беременных — почему это включается в дифференциальный диагноз при зуде без видимой сыпи?
6. Как инфекционные сыпи отличить от дерматозов беременности на догоспитальном этапе?
7. Что делать при отказе от госпитализации и какие критерии требуют обязательной госпитализации?
8. Какие назначения возможны на догоспитальном этапе и что категорически запрещено?

Общие положения

Дерматозы беременности встречаются у 20–40 % беременных и варьируют от физиологических изменений до угрожающих жизни состояний. Большинство дерматозов беременности специфичны для гестационного периода и связаны с гормональными и иммунологическими изменениями.

Ключевое различие — зудящие дерматозы против инфекционных сыпей. Зудящие дерматозы беременности обычно локализуются на животе, не сопровождаются системными признаками инфекции и имеют характерные сроки возникновения.

Инфекционные сыпи при беременности требуют немедленной оценки и исключения, так как некоторые инфекции (ветряная оспа, краснуха, ВИЧ) несут риск для плода.

Догоспитальный этап — это не постановка точного диагноза дерматоза, а исключение инфекционной природы сыпи и оценка риска для матери и плода.

Классификация дерматозов беременности

Физиологические изменения

- **Гиперпигментация** — потемнение ареол, linea nigra, мелазма (хлоазма)
- **Стрии gravidarum** (растяжки) — типичны для III триместра, локализуются на животе, бёдрах, груди
- **Васкулярные изменения** — паутинные ангиомы, пальмарная эритема
- **Увеличение сальных и потовых желёз** — может усиливать акне

Эти изменения не требуют лечения и не влияют на исход беременности.

Специфические дерматозы беременности

Дерматоз	Срок возникновения	Локализация	Характер сыпи	Зуд	Прогноз
PUPPP	III триместр, чаще multipara	Живот, особенно в области растяжек	Уртикарии, папулы, бляшки	Есть	Благоприятный, проходит после родов
Pemphigoid gestationis	II–III триместр, может начаться раньше	Живот, распространяется на всё тело	Пузыри, везикулы, эритема	Сильный	Риск для плода, требует наблюдения
Intrahepatic cholestasis	III триместр	Нет сыпи или слабая эксфолиация	Обычно нет сыпи	Сильный зуд	Риск для плода, требует лечения
Atopic eruption	Любой триместр	Любая локализация	Экзема-подобная сыпь	Есть	Благоприятный

Основные дерматозы беременности

PUPPP (Pruritic Urticarial Papules and Plaques of Pregnancy)

Самый частый специфический дерматоз беременности — встречается у 1 : 150–300 беременных.

- **Срок:** III триместр, чаще у multipara, иногда в раннем послеродовом периоде
- **Локализация:** начинается в области растяжек на животе, распространяется на бёдра, ягодицы, иногда на руки и ноги; лицо и слизистые не поражаются
- **Характер сыпи:** уртикарии, папулы, бляшки, иногда везикулы; элементы сливаются, могут напоминать крапивницу
- **Зуд:** выраженный, усиливается в вечернее и ночное время
- **Системные признаки:** отсутствуют; общее состояние не страдает

- **Прогноз:** благоприятный; сыпь проходит самостоятельно в течение 1–2 недель после родов; для следующей беременности характерен высокий риск рецидива

PUPPP: характерная сыпь в области растяжек на животе; уртикарии и папулы, сливающиеся в бляшки. Изображение доступно на DermNet NZ и Wikimedia Commons (public domain).

Дифференциальная диагностика: отличие от крапивницы — постоянная локализация на животе, длительное существование элементов, ассоциация с беременностью. Отличие от pemphigoid gestationis — отсутствие пузырей, начало в III триместре, благоприятный прогноз.

Лечение: местные кортикостероиды, антигистаминные препараты для облегчения зуда. Системные кортикостероиды не требуются. Госпитализация не нужна при удовлетворительном состоянии матери и плода.

Pemphigoid gestationis (герпесформный гестационный дерматит)

Редкий аутоиммунный буллёзный дерматоз — 1 : 50 000 беременных.

- **Срок:** чаще II триместр, может начаться в I триместре или раннем послеродовом периоде
- **Локализация:** начинается вокруг пупка, распространяется на весь живот, затем на конечности, ладони, подошвы; лицо и слизистые могут поражаться
- **Характер сыпи:** эритема, уртикарии, папулы, затем пузыри и везикулы; элементы группируются
- **Зуд:** интенсивный, часто предшествует появлению сыпи
- **Системные признаки:** могут быть — слабость, недомогание
- **Прогноз:** риск для плода — преждевременные роды, гипотрофия; риск для матери — обострения в последующих беременностях; сыпь может обостряться в первые месяцы после родов

Pemphigoid gestationis: пузыри и везикулы на эритематозном фоне; характерная локализация вокруг пупка. Изображение доступно на DermNet NZ.

Дифференциальная диагностика: отличие от PUPPP — наличие пузырей, более раннее начало, риск для плода. Отличие от других буллёзных дерматозов — связь с беременностью, наличие специфических антител.

Лечение: системные кортикостероиды (преднизолон), наблюдение акушером-гинекологом, возможная госпитализация для контроля состояния плода. Местное лечение недостаточно.

Внутрипечёночный холестаз беременных

Не совсем дерматоз, но важное состояние в дифференциальной диагностике зуда.

- **Срок:** III триместр
- **Локализация:** сыпи обычно нет; при сильном зуде — эксфолиации от расчёсывания
- **Характер:** зуд без видимой сыпи, усиливается ночью; может быть желтуха
- **Лаборатория:** повышение желчных кислот, трансаминаз, билирубина
- **Прогноз:** риск для плода — преждевременные роды, внутриутробная гибель; требует лечения урсодезоксихолевой кислотой и возможно раннего родоразрешения

Дифференциальная диагностика: отсутствие сыпи при сильном зуде, повышение печёночных проб, связь с беременностью.

Лечение: урсодезоксихолевая кислота, антигистаминные препараты, наблюдение акушером-гинекологом. Госпитализация при тяжёлом течении или нарушении состояния плода.

Инфекционные сыпи при беременности

Несмотря на то, что большинство сыпей у беременных — это дерматозы, инфекционную природу нужно исключить в первую очередь.

Краснуха

- **Сыпь:** пятнисто-папулёзная, начинается на лице, распространяется вниз
- **Сопутствующие признаки:** лихорадка, лимфаденопатия (затылочные узлы), конъюнктивит
- **Риск для плода:** высокий в I триместре — врождённые пороки развития
- **Дифференциальная диагностика:** эпидемиологический анамнез, контакт с больными, вакцинация

Краснуха: пятнисто-папулёзная сыпь на лице и туловище; характерная лимфаденопатия. Изображение доступно на CDC Public Health Image Library (public domain).

Ветряная оспа

- **Сыпь:** везикулёзная, «пёстрая» — пятна, папулы, везикулы, корки одновременно
- **Сопутствующие признаки:** лихорадка, недомогание
- **Риск для плода:** высок риск в I и II триместрах — врождённая ветряная оспа, риск пневмонии у матери
- **Дифференциальная диагностика:** характерная сыпь, контакт с больным, отсутствие вакцинации

Ветряная оспа: везикулёзная сыпь на разных стадиях развития; характерная «пёстрая» картина. Изображение доступно на TeachMeObGyn (CC BY-SA 3.0).

Коклюш

- **Сыпь:** может быть мелкая пятнистая сыпь, но не обязательный признак
- **Сопутствующие признаки:** приступообразный кашель, рвота после кашля
- **Риск для плода:** возможны осложнения у матери
- **Дифференциальная диагностика:** характерный кашель, эпидемиологический анамнез

Вирусные экзантемы

- **Сыпь:** пятнисто-папулёзная, кореподобная, моноклеозоподобная
- **Сопутствующие признаки:** лихорадка, катаральные явления, общие симптомы инфекции
- **Риск для плода:** зависит от конкретного вируса
- **Дифференциальная диагностика:** общие признаки инфекции, эпидемиологический анамнез

Алгоритм догоспитального обследования

Осмотр и сбор анамнеза

1. **Первый вопрос:** когда появилась сыпь, как прогрессировала, что предшествовало
2. **Локализация:** тщательно осмотреть всё тело, включая слизистые
3. **Характер сыпи:** диаскопия, морфология элементов, динамика

4. **Сопутствующие симптомы:** лихорадка, кашель, насморк, боль в горле, артралгии, общее состояние
5. **Акушерский анамнез:** срок беременности, течение беременности, движения плода
6. **Эпидемиологический анамнез:** контакты с инфекционными больными, поездки

Ключевые отличия

Признак	Дерматозы беременности	Инфекционные сыпи
Лихорадка	Редко, если есть — обычно субфебрильная	Часто, часто высокая
Системные признаки	Отсутствуют или минимальны	Присутствуют (кашель, насморк, слабость)
Локализация	Часто ограничена (живот)	Генерализованная
Динамика	Медленная, постоянная	Быстрая, прогрессирующая
Эпидемиологический анамнез	Отрицательный	Часто положительный
Диаскопия	Бледнеют (сосудистые)	Бледнеют (сосудистые) или нет (геморрагические)

Критерии госпитализации

Обязательная госпитализация требуется при:

1. **Подозрении на инфекционную природу сыпи** с лихорадкой и системными признаками
2. **Тяжёлом состоянии матери** — нарушение гемодинамики, дыхательная недостаточность
3. **Признаках поражения плода** — изменение сердцебиения, уменьшение движений
4. **Подозрении на pemphigoid gestationis** — пузыри, быстрое распространение
5. **Подозрении на внутрипечёночный холестаз** — сильный зуд без сыпи, желтуха
6. **Отсутствии возможности наблюдения** — социальные показания

При отказе от госпитализации при удовлетворительном состоянии матери и плода, отсутствии признаков инфекции и характерной картине PUPPP — возможна динамическая оценка на месте с рекомендацией консультации дерматолога и акушера-гинеколога в женской консультации.

Назначения на догоспитальном этапе

Разрешённые

- **Антигистаминные препараты** — для облегчения зуда (лоратадин, цетиризин)
- **Местные средства** — кортикостероидные мази при выраженной сыпи
- **Обильное питьё** — при лихорадке
- **Жаропонижающие** — парацетамол при высокой температуре

Запрещённые

- **Системные кортикостероиды** — без консультации специалиста
- **Антибиотики** — без подтверждения бактериальной инфекции

- Любые препараты с неизвестной безопасностью при беременности
- НПВС — могут ухудшать состояние при некоторых дерматозах

Ответы на вопросы

1. Когда появилась сыпь, как прогрессировала, что предшествовало её появлению. Временной фактор — ключевой для дифференциальной диагностики.
2. Сыпь на животе у беременной требует исключения специфических дерматозов беременности (PUPPP, pemphigoid gestationis) и инфекционных сыпей (краснуха, ветряная оспа). В первую очередь нужно исключить инфекцию из-за риска для плода.
3. PUPPP — самый частый специфический дерматоз беременности, возникает в III триместре у multipara, локализуется на животе в области растяжек, проявляется уртикариями и папулами, зудит, имеет благоприятный прогноз, проходит после родов.
4. Pemphigoid gestationis — редкий аутоиммунный дерматоз, возникает во II-III триместрах, начинается вокруг пупка, характеризуется пузырями и везикулами, несёт риск для плода (преждевременные роды, гипотрофия), требует системных кортикостероидов и наблюдения.
5. Внутрипечёночный холестаз беременных включается в дифференциальный диагноз при сильном зуде без видимой сыпи, может сопровождаться желтухой, несёт риск для плода, требует лечения урсодезоксихолевой кислотой и возможного раннего родоразрешения.
6. Инфекционные сыпи отличают по наличию системных признаков (лихорадка, катаральные явления), эпидемиологическому анамнезу, быстрой динамике, генерализованной локализации. Дерматозы беременности — локализованные, без системных признаков, медленно прогрессирующие.
7. При отказе от госпитализации необходимо оценить состояние матери и плода, исключить инфекцию, обеспечить возможность наблюдения. Обязательная госпитализация — при признаках инфекции, тяжёлом состоянии, подозрении на pemphigoid gestationis или холестаз.
8. На догоспитальном этапе можно назначить антигистаминные препараты и местные кортикостероиды. Категорически запрещены системные кортикостероиды, антибиотики без подтверждения, препараты с неизвестной безопасностью при беременности, НПВС.

Основные выводы

№	Вывод
1	Сыпь на животе у беременной — чаще PUPPP, но сначала исключить инфекцию. Лихорадка, системные признаки, эпидемиологический анамнез в пользу инфекции.
2	PUPPP — III триместр, растяжки, уртикарии, зуд, благоприятный прогноз. Pemphigoid gestationis — пузыри, риск для плода, требует кортикостероидов.
3	Внутрипечёночный холестаз — зуд без сыпи, повышение печёночных проб, риск для плода, требует урсодезоксихолевой кислоты.
4	Инфекционные сыпи исключают по анамнезу, системным признакам, динамике. Краснуха, ветряная оспа несут риск для плода.
5	На догоспитальном этапе — антигистаминные и местные средства. Системные кортикостероиды и антибиотики — только по специалисту.